

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ACC® 200

Hoạt chất: acetylcystein

Bột pha dung dịch uống

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng in trên hộp thuốc

Thành phần công thức thuốc

Thành phần dược chất: Mỗi gói 3 g bột pha dung dịch uống chứa 200 mg acetylcystein.

Thành phần tá dược: acid ascorbic, saccharin, sucrose, bột hương cam.

Dạng bào chế

Bột pha dung dịch uống. Bột đồng nhất, màu trắng, không bị kết tụ thành hạt, hương cam.

Chỉ định

Điều trị tiêu đàm (đờm) (secretolytic therapy) trong các bệnh phế quản - phổi cấp và mạn tính kèm theo suy yếu hình thành và vận chuyển chất nhầy.

Cách dùng, liều dùng

Nếu không có chỉ dẫn nào khác của bác sỹ, liều thông thường như sau:

Liều lượng:

- Người lớn và thiếu niên trên 14 tuổi: 1 gói x 2 - 3 lần/ ngày (400 - 600 mg acetylcystein/ngày).
- Trẻ em 6 - 14 tuổi: 1 gói x 2 lần/ ngày (400 mg acetylcystein/ngày).
- Trẻ từ 2-5 tuổi nên dùng hàm lượng khác phù hợp.

Phương pháp và thời gian dùng thuốc:

Thuốc có thể được hòa tan vào nước, và uống sau các bữa ăn.

Không dùng thuốc quá 4 – 5 ngày khi không có tham vấn về y khoa

Bệnh viêm phế quản mạn cần dùng ACC® 200 với thời gian dài hơn để đạt tác dụng phòng ngừa nhiễm trùng.

Chống chỉ định

Không sử dụng ACC® 200 nếu:

- Mẫn cảm với acetylcystein hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 2 tuổi vì không đủ kinh nghiệm dùng thuốc cho những đối tượng này.
- Đang bị viêm loét dạ dày

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Bệnh nhân bị hen phế quản phải được theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị. Nếu có thất phế quản xảy ra, cần dùng sử dụng acetylcystein ngay lập tức và bắt đầu các biện pháp điều trị thích hợp. Cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm này ở những bệnh nhân có tiền sử bị loét dạ dày-ruột, đặc biệt khi dùng cùng với các thuốc có gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa.

Việc sử dụng acetylcystein, đặc biệt là trong điều trị sớm có thể dẫn đến hóa lỏng do đó dẫn đến tăng thể tích dịch tiết phế quản. Nếu bệnh nhân không thể khạc đờm (khạc đờm) đủ mạnh, cần áp dụng các biện pháp thích hợp (như hút đờm hoặc dẫn lưu).

Rất hiếm có báo cáo về phản ứng da nặng như hội chứng Stevens-Johnson và Lyell's xảy ra trong thời gian sử dụng acetylcystein. Nếu thấy gần đây có những thay đổi ở da và niêm mạc, hãy lập tức tham khảo ý kiến bác sỹ và ngưng sử dụng acetylcystein.

Nên thận trọng đối với bệnh nhân không dung nạp histamin. Những bệnh nhân này nên tránh điều trị acetylcystein trong thời gian dài, bởi vì acetylcystein ảnh hưởng đến chuyển hóa histamin và có thể dẫn đến các triệu chứng không dung nạp (ví dụ: đau đầu, chảy nước mũi, ngứa).

Trẻ em và thiếu niên

Điều trị tiêu đàm (đờm) có thể dẫn đến tắc nghẽn đường hô hấp ở trẻ dưới 2 tuổi, do đặc điểm của đường hô hấp và khả năng hạn chế ho khạc đờm. Do đó, không được sử dụng thuốc tiêu đàm ở trẻ em dưới 2 tuổi (xem phần Chống chỉ định)

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Tương tác thuốc

Hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc đã, đang hoặc mới dùng gần đây kể cả những thuốc không kê đơn.

Thuốc ho

Dùng đồng thời ACC® 200 với thuốc trị ho có thể gây ứ đọng dịch nhầy nghiêm trọng do giảm phản xạ ho, vì vậy kiểu kết hợp điều trị này nên được dựa vào những chẩn đoán thật chính xác.

Thuốc kháng sinh

Các báo cáo về acetylcystein làm mất hoạt tính của kháng sinh chỉ dựa trên các thực nghiệm *in vitro* trong đó các chất được pha trộn trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nên uống kháng sinh cách xa acetylcystein ít nhất là 2 giờ. Không xuất hiện tương tác như vậy đối với cefixim và loracarbef.

Acetylcystein/glyceryl trinitrat

Dùng đồng thời acetylcystein có thể có khả năng dẫn đến tăng cường tác dụng giãn mạch và ức chế kết tập tiểu cầu của glyceryl trinitrat (nitroglycerin).

Nếu cân nhắc thấy việc điều trị đồng thời acetylcystein với glyceryl trinitrat là cần thiết, bệnh nhân nên được theo dõi về khả năng bị tụt huyết áp, có thể nghiêm trọng, và được thông báo về khả năng bị đau đầu.

Than hoạt tính

Than hoạt tính liều cao (chất giải độc đặc hiệu) có thể làm giảm hiệu quả của acetylcystein.

Thay đổi các thông số xét nghiệm

Acetylcystein có thể ảnh hưởng đến việc xác định salicylat bằng phương pháp so sánh màu.

Trong các xét nghiệm nước tiểu, acetylcystein có thể ảnh hưởng đến kết quả xác định các thể keton.

Tương kỵ

Không khuyến cáo hòa tan các chế phẩm chứa acetylcystein với các thuốc khác.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai

Không có đủ dữ liệu về việc sử dụng acetylcystein cho phụ nữ có thai. Nghiên cứu trên động vật thí nghiệm không chỉ ra tác dụng có hại một cách trực tiếp hay gián tiếp trên việc mang thai, sự phát triển của phôi/ thai và sau sinh. Acetylcystein nên được dùng trong thai kỳ sau khi đã được đánh giá một cách cẩn thận về lợi ích so với nguy cơ.

Cho con bú

Không có thông tin về sự bài tiết của acetylcystein vào sữa mẹ. Chỉ nên dùng acetylcystein trong thời kì cho con bú sau khi đã được đánh giá một cách cẩn thận về lợi ích so với nguy cơ.

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu về tác dụng của acetylcystein đối với khả năng sinh sản của con người. Trong các nghiên cứu trên động vật, không có tác dụng không mong muốn nào đối với khả năng sinh sản được quan sát ở liều điều trị của acetylcystein.

Ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa rõ ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Thông tin quan trọng về thành phần của ACC® 200

Thuốc có chứa sucrose. Bệnh nhân không dung nạp với một số đường, hãy thông báo cho bác sĩ trước khi dùng ACC® 200.

Một gói thuốc có chứa 2,7 g sucrose (một loại đường), tương đương với 0,23 đơn vị trao đổi carbohydrat. Nếu phải thực hiện chế độ ăn kiêng, cần phải lưu ý.

ACC® 200 có thể gây hại cho răng (sâu răng).

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Việc đánh giá tác dụng không mong muốn được dựa trên các thông tin về tần suất sau:

Rất thường gặp:	(≥ 1/10)
Thường gặp:	(≥ 1/100 đến < 1/10)
Ít gặp:	(≥ 1/1.000 đến < 1/100)
Hiếm gặp:	(≥ 1/10.000 đến < 1/1.000)
Rất hiếm gặp:	(< 1/10.000)
Chưa biết:	(không thể đánh giá được dựa trên dữ liệu hiện có)

Rối loạn hệ miễn dịch

Ít gặp:	tăng mẫn cảm
Rất hiếm gặp:	Sốc phản vệ, phản ứng phản vệ/ dạng phản vệ

Rối loạn hệ thần kinh

Ít gặp:	đau đầu
---------	---------

Rối loạn tai và mê đạo

Ít gặp:	ù tai
---------	-------

Rối loạn tim mạch

Ít gặp:	nhip tim nhanh
<u>Rối loạn mạch máu</u>	
Rất hiếm gặp:	xuất huyết
<u>Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất</u>	
Hiếm gặp:	khó thở, co thắt phế quản
<u>Rối loạn hệ tiêu hóa</u>	
Ít gặp:	buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm miệng
Hiếm gặp:	khó tiêu
<u>Rối loạn da và các mô dưới da</u>	
Ít gặp:	mày đay, phát ban, phù mạch, ngứa, chứng phát ban
<u>Rối loạn toàn thân và tại vị trí dùng thuốc</u>	
Ít gặp:	sốt
Chưa biết:	phù mắt
<u>Xét nghiệm, thăm khám:</u>	
Ít gặp:	Tụt huyết áp

Trong số các trường hợp rất hiếm gặp, các phản ứng da nặng như hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc đã được báo cáo có mối liên quan trong thời gian sử dụng acetylcystein. Trong hầu hết các ca báo cáo này, ít nhất một thuốc khác, mà thuốc này có khả năng làm tăng tác dụng trên niêm mạc, đã được sử dụng trong cùng khoảng thời gian đó.

Nếu xuất hiện những bất thường về da hoặc niêm mạc, cần tham vấn y khoa ngay lập tức và ngừng sử dụng acetylcystein. Sự giảm kết tập tiểu cầu trong máu do sự hiện diện của acetylcystein đã được xác nhận bởi nhiều nghiên cứu khác nhau. Cho đến nay mối liên quan đến lâm sàng vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Quá liều và cách xử trí:

Không quan sát thấy trường hợp quá liều độc hại nào liên quan đến acetylcystein dùng đường uống. Không quan sát thấy bất kỳ tác dụng không mong muốn nặng ở những người tình nguyện đã điều trị với liều 11,6 g acetylcystein/ngày trên 3 tháng. Liều uống đến 500 mg acetylcystein/kg cân nặng đều được dung nạp mà không có triệu chứng của nhiễm độc.

Triệu chứng của nhiễm độc:

Quá liều có thể dẫn đến triệu chứng đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy). Trẻ nhũ nhi có nguy cơ tăng tiết nặng hơn.

Điều trị nhiễm độc: điều trị triệu chứng nếu cần thiết.

Nếu quên dùng ACC® 200

Nếu quên uống thuốc hoặc uống một lượng quá ít, tiếp tục uống thuốc vào lần tiếp theo như hướng dẫn về liều dùng.

Nếu ngưng dùng ACC® 200

Không nên ngưng dùng thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Bệnh có thể nặng thêm.

Nếu cần thêm thông tin về thuốc, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.

Các đặc tính dược lực học

Nhóm trị liệu: Thuốc tiêu chất nhầy

Mã ATC: R05CB01

Acetylcystein là một dẫn chất của amino acid cystein. Hiệu quả của acetylcystein là tiêu đàm (đờm) (secretolytic) và kích thích tiết chất nhầy (secretomotoric) ở đường hô hấp. Thuốc được cho là cắt các cầu nối disulphid giữa các dây mycopolysaccharid và có tác dụng khử trùng hợp các polymer trong chuỗi DNA (trong chất nhầy mũi). Dựa vào những cơ chế này, độ nhầy nhớt của chất nhầy giảm.

Một cơ chế khác của acetylcystein là dựa vào khả năng của nhóm SH phản ứng của nó để liên kết với các gốc hóa học và khử độc chúng theo cách này.

Hơn nữa, acetylcystein góp phần làm tăng tổng hợp glutathion, là chất quan trọng để khử độc. Điều này giải thích cho tác dụng chống độc đặc hiệu đối với việc ngộ độc paracetamol.

Các đặc tính dược động học

Hấp thu

Sau khi dùng đường uống, hầu hết acetylcystein được hấp thu nhanh chóng và chuyển hóa ở gan thành cystein, một chất chuyển hóa có hoạt tính dược lý, cũng như chuyển hóa thành diacetylcystin, cystin và các hỗn hợp disulphid khác.

Phân bố

Do chuyển hóa bước một mạnh, sinh khả dụng đường uống của acetylcystein rất thấp (xấp xỉ 10%). Ở người, nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau 1-3 giờ với nồng độ tối đa trong huyết tương của chất chuyển hóa cystein nằm trong khoảng xấp xỉ 2 µmol/l. Liên kết giữa acetylcystein với protein được xác định vào khoảng 50%.

Chuyển hóa

Acetylcystein và các chất chuyển hóa của nó tồn tại dưới ba dạng khác nhau trong cơ thể: một phần ở dạng tự do, một phần liên kết với protein thông qua liên kết disulphid không ổn định và một phần dạng amino acid kết hợp. Acetylcystein được bài tiết hầu hết ở dạng chất chuyển hóa không có hoạt tính (sulphat vô cơ, diacetylcystin) thông qua thận. Thời gian bán thải trong huyết tương của acetylcystein xấp xỉ 1 giờ và chủ yếu được xác định bởi sự chuyển hóa nhanh chóng ở gan. Do đó, ở người suy giảm chức năng gan, thời gian bán thải trong huyết tương có thể kéo dài đến 8 giờ.

Thải trừ

Nghiên cứu dược động học với đường tiêm tĩnh mạch của acetylcystein cho biết thể tích phân bố là 0,47 l/kg (tổng quát) hoặc 0,59 l/kg (ở người ốm yếu); độ thanh thải huyết tương được xác định tương ứng là 0,11 l/giờ/kg (tổng quát) và 0,84 l/giờ/kg (ở người ốm yếu).

Thời gian bán thải sau khi tiêm tĩnh mạch là 30-40 phút khi được bài tiết theo động học 3 pha (alpha, beta, và pha cuối gamma).

Acetylcystein qua được hàng rào nhau thai và được tìm thấy ở máu cuống rốn. Không có thông tin liên quan đến việc bài tiết thuốc vào sữa mẹ.

Không có thông tin nào liên quan về tác động của acetylcystein đến hàng rào máu não ở người.

Quy cách đóng gói:

Hộp 20 gói, hộp 50 gói, hộp 100 gói.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

Bảo quản: Không bảo quản trên 30°C

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Cơ sở sản xuất:

Lindopharm GmbH

Neustr. 82, 40721 Hilden, Đức

Cơ sở chịu trách nhiệm xuất xưởng lô:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Đức

Tờ hướng dẫn sử dụng được cập nhật theo CDS v05_11_2019

2021 05 04

50092875 40131624

Code: 4610